

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	脊髓小腦退化性動作協調障礙症 Spinocerebellar Ataxia；SCA				
編號	A31000-Q03-W-A11	制定者	R14 李嘉綺	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.3 版/13 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解脊髓小腦退化性動作協調障礙症的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

脊髓小腦退化性動作協調障礙症(spinocerebellar ataxia, SCA)，又稱小腦萎縮症，衛生福利部稱為脊髓小腦共濟失調症，為一罕見疾病，台灣未有盛行率之調查報告，國外之盛行率則大於十萬分之六。SCA 具高度遺傳性，因步態不穩、搖晃，又被稱為企鵝家族，現仍無治癒之可能性，只能藉支持性療法延緩症狀惡化，只要在親代當中一人罹病，其後代子女皆有 50%的機率發病，一般患者在成年期發病，發病年齡約在二十至四十歲開始。

（二）症狀

進程約略可分為初、中、晚三期，分述如下：

1. 初期

- (1)走路有喝醉酒的感覺（眩暈）。
- (2)動作反應較不靈活，動作的流暢性喪失，提（舉）重物有困難。
- (3)上下樓梯（公車）雙腿不協調，肌肉僵硬，無法精確地完成某特定動作（動

主題名稱	脊髓小腦退化性動作協調障礙症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A11	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	2/13

作笨拙），例如：

- A. 體操、跑步、打球、爬山。
- B. 靜止站立時，身體會前後搖晃（軀幹失調），行走端湯、端茶時，容易濺／潑出容器。
- C. 行走時容易撞到牆壁或門框。
- D. 眼球轉動障礙（前庭功能障礙）—無法快速、準確地轉移目標。
- E. 有些病人白天倦怠，晚上清醒，甚至無法入眠，有失眠現象。
- F. 在睡眠時有抽筋現象。
- G. 辨距不良（如打不到乒乓球）。

2. 中期

- (1) 四肢肌肉不協調感加重，運動失調現象明顯。
- (2) 無法控制姿勢與步伐，行動出現搖搖晃晃不穩的現象，無法保持平衡，無法長距離行走。無法跑步，上下樓梯有困難，走路時，身體無法靈活調整，因此容易摔跤。
- (3) 舌頭打結、說話不清楚、寫字有困難、吃東西或喝水時容易被噎到。

3. 晚期

- (1) 說話不清楚無法控制音調，甚至無法言語，寫字無法辨認，吞嚥困難。
- (2) 無法站立（無法坐起），要靠輪椅代步，或臥病在床，生活無法自理。
- (3) 若大腦或周邊神經受到波及，則病人智力（認知）會受到影響，例如 SCA-12、13、17 型。
- (4) 其中 SCA-13 型大部分為孩童期發病，導致智能發展遲鈍，但 SCA-3 型不會發生智力退化情形。

（三）常見檢查

- 1. DNA 分析：為最精確的診斷法，可以分辨不同的類型，目前歸納有二十種以上。
- 2. 核磁共振攝影：利用核磁共振成像掃描腦部，可以見到病變進行中的小腦萎縮。
- 3. 小腦功能評估。

主題名稱	脊髓小腦退化性動作協調障礙症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A11	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	3/13

(1)上肢肢體方面：

- A. 請受測者將兩上肢前伸，並閉上眼睛，接著可突然用力向上或向下推受測者的手，前伸的手會來回晃盪數下才停止，表示有小腦的病灶。
- B. 手指到鼻的測試：請受測者以手指頭摸自己的鼻子再摸施測者的食指。施測者可移動目標的食指，要求加快動作速度或在受測者上臂施以部分阻力，以增加此測驗之敏感度。
- C. 反覆性動作：可請受測者做依序反覆做出如剪刀－石頭－布；以“掌心－手背”拍打大腿等動作，動作不連貫或不規則可能有小腦病變。

(2)下肢肢體方面：

- A. 跟部到脛骨：請受測者將腳抬起，腳跟置於膝蓋骨上，然後沿著脛骨內側平穩地向下滑至腳踝，若上述動作不連貫或腳跟於半途便掉至床上者表有小腦功能異常。
- B. 請受測者以腳規律拍打地面，聽其聲音是否規律連貫。

(3)身體軀幹方面：

觀察受測者不用手支撐自行平躺坐起，上述測試在有肢體無力的情況下，無法代表小腦功能異常。

4. 步態評估：

- (1)觀察重點：觀察兩腳間距離、步伐大小及規律性、手臂之擺動情形、以及骨盆之動作，膝蓋之高度。
- (2)測試方法：臨床上觀察異常步態，可使用柏格氏平衡量表 (Berg balance scale)、6 公尺行走測試、起身走路測試 (timed up and go test)來了解個案步行能力。讓受測者走一直線，如走鋼索般，一腳腳跟放在另一腳腳尖前緩慢前行，並以腳跟走路，及腳尖走路，請受測者單腳跳，做隆伯氏測驗(Romberg test)：雙腳併攏，先將雙眼睜開然後再緊閉，觀察約 20 秒看是否能穩定維持直立姿勢。

主題名稱	脊髓小腦退化性動作協調障礙症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A11	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	4/13

(四) 常見藥物

目前未有根治的藥物，治療的重點在復健治療，重視身體的保養，注意飲食、起居，定期做運動，持之以恆地練習，將有助延緩病情惡化的速度，使病人盡可能維持最高的生活自理能力。

(五) 護理問題

1. 身體活動能力異常／神經肌肉障礙。
2. 易跌倒／神經肌肉障礙。
3. 吞嚥功能障礙／神經肌肉病變。
4. 自我照顧尋求協助：沐浴及衛生／活動無耐力。
5. 自我照顧尋求協助：穿著及修飾／活動無耐力。
6. 自我照顧尋求協助：進食／神經肌肉障礙。
7. 自我照顧尋求協助：如廁／與身體活動功能障礙有關。
8. 語言溝通困難／與疾病導致退化有關。
9. 無力感／遵從醫囑治療，但身體狀況仍無改善。

(六) 護理措施

1. 身體活動能力異常／神經肌肉障礙

- (1)監測患肢 6Psigns (pain 疼痛、paresthesia 感覺異常、paralysis 麻痺、pallor 蒼白、pulslessness 無脈搏、poikilothermia 溫度改變)並評估身體活動障礙程度。
- (2)建議漸進式活動，教導並示範移動技巧。
- (3)協助並教導病人從主動全關節運動漸進至功能性活動。
- (4)示範增加活動力的方法及 ROM 等長運動、等張運動。
- (5)教導活動時注意安全之措施。
- (6)協助並教導正確使用輔助器。
- (7)活動後抬高患肢，促進末梢血循，減輕腫脹。
- (8)教導病人患肢執行被動關節運動。
- (9)教導病人健肢執行主動關節運動。

主題名稱	脊髓小腦退化性動作協調障礙症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A11	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	5/13

(10)依醫囑予骨骼肌鬆弛劑。

(11)依醫囑使用固定器或夾板固定關節不動可減輕疼痛，並避免無功能姿勢的攣縮。

(12)提供急性患肢關節休息和支托穩定及降低關節壓力及增加肌肉鬆弛。

(13)平衡休息治療與主動身體運動計劃以增進體力及功能。

(14)評值病人身體活動功能活動後反應。

2. 易跌倒／神經肌肉障礙

(1)病人臥床時使用床欄並注意床欄穩固。

(2)降低病床高度。

(3)使用夜燈的設置。

(4)防滑墊、止滑鞋的穿著。

(5)清除病床到浴室間的障礙物，保持地面乾燥及適當照明。

(6)護理人員每班至少兩小時查看病人情形。

(7)將尿壺或便盆置於可拿取位置且倒空。

(8)讓病人及家屬瞭解目前行動能力及限制，應採漸進式行動，且有人在旁扶助。

(9)教導病人使用叫人鈴（紅燈）並置於適當位置。

(10)讓病人及家屬瞭解正在服用易導致跌倒的藥物，如降血壓及安眠藥等。

(11)衛教病人在服用藥物後半小時內改變姿勢宜緩慢。

(12)必要時依醫囑給予適當的約束。

(13)依照顧者國籍給予預防跌倒照護單張。

3. 吞嚥功能障礙／神經肌肉病變

(1)確認病人和家屬了解病因。

(2)觀察吞嚥困難引起之合併症；如咳嗽、吸入異物。

(3)教導病人和家屬照顧行為並評估完成情形。

(4)觀察病人和家屬之學習照顧行為。

(5)鼓勵練習吞嚥動作。

主題名稱	脊髓小腦退化性動作協調障礙症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A11	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	6/13

(6)觀察病人吞嚥行為和評值問題。

(7)應用吞嚥障礙規範執行和紀錄評估。

(8)指導減輕引起吞嚥困難之方法及措施，例如：插 NG-Tube。

(9)假如需要應教導病人照顧措施。

4. 自我照顧尋求協助：沐浴及衛生／活動無耐力

(1)與病人一同監測和討論情境的變化、能做哪些活動及如何執行。例如：是否可清洗到下肢或背部。

(2)與病人一起做護理計劃和確認結論，以增加病人對情境的控制感。

(3)鼓勵做可強化弱肢的運動，增進其平衡感與靈敏度。

(4)視需要提供教學、督導與協助。

(5)給予病人讚美與鼓勵做為強化與回饋。

(6)當病人想要沐浴時，協助其沐浴，並且提供最大的隱密性以鼓勵其更加主動參與。

(7)使用浴缸或淋浴（坐在有椅臂椅子，如：便盆椅，以策安全），將所需的物品置於伸手可取得的地方。

(8)評估危險性，並且採取預防措施，將危險減至最低。

(9)監督病人自我照顧活動（沐浴或清潔），以確定其精力耗費程度與耐力程度。

(10)以減少疲勞，減輕挫折感與促進其遵從性。

(11)增加支持來源的層次，減少病人進一步失能的速率，並且維持病人的參與。

5. 自我照顧尋求協助：穿著及修飾／活動無耐力

(1)與病人一同監測和討論情境的變化、能做哪些修飾及如何執行。

(2)與病人一起做護理計劃和確認結論，以增加病人對情境的控制感。

(3)鼓勵做可強化弱肢的運動，增進其平衡感與靈敏度。

(4)視需要提供教學、督導與協助。

(5)給予病人讚美與鼓勵做為強化與回饋。

(6)提供有簡單綁繫之物的寬鬆衣服，並給予充分的時間以穿戴完整。

主題名稱	脊髓小腦退化性動作協調障礙症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A11	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	7/13

(7)評估危險性，並且採取預防措施，將危險減至最低。

(8)督促病人穿著及修飾活動（梳髮、化妝、刮鬍子），並視需要提供協助，以確保病人能做得令人滿意，並使外觀顯得整潔乾淨。

(9)增加支持來源的層次，減少病人進一步失能的速率，維持病人的參與。

6. 自我照顧尋求協助：進食／神經肌肉障礙

(1)與病人討論情況的變化，並且告訴其任何有關治療的預期效果，以增加照顧者的信賴。

(2)與病人一起做護理計劃和確認結論，以增加病人對情境的控制感。

(3)在訂定措施時，應考慮病人的認知或知覺功能不良、口腔運動障礙或手臂與手的控制力不佳；協助病人選擇輔助器皿、選擇與準備食物和飲料，以促進其獨立性與安全性。

(4)視需要提供教學、督導與協助。

(5)給予病人讚美與鼓勵做為強化與回饋。

(6)監督每餐的進食活動，以確定其進展程度。

(7)病人或家屬一同確認其對食物的偏好、進食時間、地點與共同進餐者，儘可能提供病人習慣的方式。

7. 自我照顧尋求協助：如廁／與身體活動功能障礙有關

(1)監督病人如廁活動，並且視需要提供督導與協助，以確定其進展程度。

(2)當病人能獨立執行如廁活動時，給予支持與鼓勵。

(3)確認病人的排尿與排便型態，並協助建立排尿與排便計劃；當病人要求協助時立即回應，協助其達到控制與避免失禁發生。

(4)當病人如廁時，提供其隱密性。

(5)對病人失禁的現象不加以評論，避免造成病人困窘及強忍如廁的需要。

(6)將呼叫鈴置於病人伸手可及之處，避免發生跌倒。

(7)視需要協助病人清潔，重整衣物，確保乾淨舒適和整潔的外觀。

主題名稱	脊髓小腦退化性動作協調障礙症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A11	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	8/13

8. 語言溝通困難／與疾病導致退化有關

- (1)評估病人意識狀態、語言文化、教育程度及肢體動作所表達意義。
- (2)評估並找出雙方可溝通方式（語言、非語言等）。
- (3)教導並提供數種表達需要的方式，如筆或簡易圖片來進行溝通。
- (4)教導以問答方式，必要時可加上肢體動作來達成有效溝通。
- (5)剛開始問病人問題時，應選擇答案簡單、只有幾個字之問題。
- (6)每次示範並支持有效雙向溝通的重要性。
- (7)適當給予鼓勵及讚美以增加病人自尊及信心。
- (8)提供病人練習有效溝通技巧之機會。
- (9)示範及鼓勵以非語言行為代替或加強語言上之表達。
- (10)在溝通過程中，應鼓勵及教導使用正確適當的方法表達生氣及挫折。
- (11)每次護理前後予再解釋，並確定瞭解治療的原因及目的。
- (12)必要時請家屬（或朋友）來加以翻譯，達成適當溝通。
- (13)每次溝通前後注意病人反應及表情、潛在含意。
- (14)每班記錄和病人溝通的狀況並評值其與護理活動互動情形。
- (15)當護理人員無法瞭解病人意思時，應給予適當無條件正向鼓勵及讚美，以增加引導，並安撫。

9. 無力感／遵從醫囑治療，但身體狀況仍無改善

- (1)瞭解病人治療的內容並評估治療的效果。
- (2)請醫師給予解釋目前治療的目的及未來治療計畫，使病人安心。
- (3)執行任何治療前均應給予解釋，並記錄結果及反應。
- (4)瞭解是否有其它潛在的疾病，影響治療的效果並協助醫師處理。
- (5)親自觀察病人是否按時及確實服藥或接受治療。
- (6)觀察是否有因治療引發的副作用，告知醫師給予處理，減輕不適感指導病人學習記錄治療後身體的反應，提供醫師做為治療參考。
- (7)提供所有治療的相關資訊或書面資料，讓病人瞭解並安心接受治療。

主題名稱	脊髓小腦退化性動作協調障礙症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A11	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	9/13

(8)必要時給予適當的保證，使病人安心接受治療。

(9)介紹接受相同治療的病人給予認識，彼此交換意見。

(七) 衛教指導

1. 行動照護上，注意要經常變換姿勢及活動方式，不要固定在相同的姿勢太久。
2. 睡眠照護上，若白天下床活動太累時，中午最好能臥床休息一下；但是假若晚上睡眠不太好，則切忌午睡太長。最好每天安排些例行的事來做，如：娛樂（寫網誌、種花等）或工作都好，讓自己必須用心力去達成任務（有點困難更好），能提高士氣，製造生活樂趣與成就感。
3. 避免因上廁所不便或吞嚥問題而減少水分攝取，至少飲用 2000cc 以上；此外養成每日規律排便、腹部按摩、輕微運動皆有助預防便秘。
4. 針對病人的吞嚥困難產生食物噎到的方面，需注意烹煮或選擇食物質地應柔軟、呈糊狀，調整食物濃稠程度，小口緩慢進食，注意攝食時的姿勢，盡量能坐直。
5. 運動的程度視身體狀況來調節，重要的是顧及安全，以及要能持之以恆。
6. 不論是病人本身或家屬，面對診斷結果的衝擊下，彷彿人生已經沒有希望；此時，家人與親友的愛與支持、尋求宗教的力量等等，都是提供病人心靈重要的安定力量；而家屬或主要照顧者也要懂得情緒管理，自我放鬆，找時間運動、休閒，在需要的時候找親朋好友吐露心靈垃圾，若自我情緒陷入更低潮，必要時需尋找專業心理諮商或專業醫師。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	脊髓小腦退化性動作協調障礙症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A11	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	11/13

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	修改說明內容。	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	1. 護理部改護理部。 2. 修改護理措施部份內容。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31	3.1	新增參考資料。	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	1. 說明內容修正錯別字及標點符號 2. 參考資料文獻部份內容更新。。	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
104.08.31	3.3	第六項參考資料修訂 APA 格式。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.4	1. 參考文獻新增於內文。 2. 第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.5	1. 第三項第(一)目內容修訂。 2. 第三項第(六)目新增 6P signs 內容。 3. 新增第六項參考資料。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.6	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。

主題名稱	脊髓小腦退化性動作協調障礙症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A11	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	12/13

修正日期	版本	修正說明	備註
108.09.23	3.7	1. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 2. 第六項參考資料增刪及修訂	108 年 09 月 11 日照護標準組會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	3.8	第三項第三目之 2 刪除 MRI。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.10.19	3.9	第六項參考資料修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	4.0	1. 第三項第五目、第六目修訂護理診斷。 2. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	4.1	第三項第五目、第六目修訂護理問題。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過；112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.12.17	4.2	第六項參考資料增刪及修訂。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過；113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。

主題名稱	脊髓小腦退化性動作協調障礙症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A11	版本	第 4.3 版	頁碼/總頁數	13/13

修正日期	版本	修正說明	備註
115.01.06	4.3	第三項第五目第 8 點、第六目第 8 點修訂護理診斷。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。